PRÁCTICA 1

RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA			
#	**Criterios**	**Sí**	**No**
1	Se presenta con el paciente.		
2	Realiza HC de forma ordenada y completa, solicita signos vitales, somatometría y glucosa capilar. Si falta alguna = NO		
3	Realiza exploración cefalocaudal general		
4	Menciona factores de riesgo para realización de oftalmoscopia en general (al menos 3) e identifica los del px: - Disminución de agudeza visual - Diabetes Mellitus - Hipertensión Arterial - Cefalea - Síntomas neurológicos agudos para descartar edema de papila - Degeneración macular asociada a la edad - Repercusión de otras enfermedades hematológicas. neurológicas.		
5	Pide autorización al paciente para realizar oftalmoscopia, se lava las manos (si falta algo = NO)		
6	Revisa que su material esté completo: - Oftalmoscopia: Cabezal, Mango. - Pone habitación en penumbras		
7	Menciona que se debe aplicar Midriasis farmacológica (menciona al menos 2): - Poder efectuar la oftalmoscopia con facilidad (midriasis pupliar) - Paralizar el músculo cillar y poder averiguar la refracción dei ojo evitando su acomodación. - Menciona al menos 2 fármacos: Ciclopentano, Tropicamida, Fenilefrina. Menciona en qué casos no usaría (menciona al menos 2): - Cámara anterior estrecha (puede desencadenar un ataque. agudo de glaucoma) - Antecedentes de glaucoma de ángulo estrecho sin iridotomía profiláctica - Rubeosis en iris - Antes de realizas valoración neurológica		
8	Pedir al paciente que mire un punto lejano (fijo). El oftalmoscopio se sujeta con la mano derecha y se mira con el ojo derecho, y viceversa.		
9	A una distancia de 15 cm aproximadamente de observar el fulgor pupilar, manteniendo a un ángulo de 15 grados respecto al eje sagital, el examinador se acerca al ojo del paciente hasta 2-3 cm. Sin perder de vista este reflejo, se observa la papila. Explorando fondo de ojo de manera ordenada, examinar papila, valorando nitidez de sus bordes, coloración, relleve y continuar el recorrido por el fondo de bjo siguiendo las arcadas vasculares.		
10	Los vasos retinianos principales se examinan de manera distal, en cada uno de los cuadrantes (Superior, inferior, temporal y nasal). Se examina el color, tortuosidad y el calibre de los vasos. Examina polo posterior está comprendido entre las arcadas vasculares temporales, mide 5-6 mm y es donde se localiza a mayoría de las lesiones en la retinopatía diabética, como microaneurismas, hemorragias o exudados.		
11	Describe correctamente las lesiones en el fondo ojo compatibles con RDP Parénquima retiniano heterogéneo, naranja anacarado amarillento, con presencia de múltiples exhudados algodonosos, de predominio en cuadrantes temporales. Disco óptico, con bordes mal-definidos y forma ovalada, excavación de disco óptico de posición periférica abarcando la mayor parte de este. Mácula aproximadamente a 1.0 - 1.5 diámetros de disco de distancia del disco óptico, muy discreto aumento de pigmentación, con presencia escasa de vasos atravesándola. Se observan vasos con aumento de diámetro y calibre, así como formación de neovasos de predominio en cuadrantes inferiores con pérdida de relación AV. En su trayecto se vuelve a apreciar aumento de tortuosidad		
12	Solicita estudios de laboratorio para valoración integral del paciente (QS, HbA1c, Perfil lipidico) SI falta algo = NO		
13	Menciona al menos 2 diagnósticos diferenciales (retinopatía diabética no proliferativa leve, rdnp moderada, rdnp severa, edema macular)		
14	Integra diagnósticos (si falta alguno marcar NO) - Retinopatía/diabética proliferativa - Dislipidemia mixta		
15	**Pregunta directa:** ¿Cuál es el primer dato histopatológico en la retinopatía diabética? a pérdida de pericitos		
16	Menciona tratamiento de elección par RDP: Panfotocoagulación retintana periférica		

17	**Pregunta directa:** ¿Cuál es la principal causa de baja visual en pacientes con diabetes? El edema macular		
18	Clasificación de edema macular según su gravedad LEVE: Cierto engrosamiento retiniano o exudados duros en polo posterior, pero distantes del centro de la mácula MODERADO: Engrosamiento retiniano o exudados duros próximos al centro de la macula, pero sin involucrarlo. SEVERO: Engrosamiento retiniano y exudados duros involucrando el centro de la mácula		
19	Otorga tratamiento para Diabetes Mellitus y Dislipidemia mixta (SI FALTA ALGUNO = NO) inicia esquema de insulina 0.1-0.2 UI/kg/dia y Atorvastatina 40 mg/dia Dieta DASH o mediterránea		
20	Conoce las metas de tratamiento para Diabetes Mellitus según la ADA (si falta alguna y/o no otorga tratamiento para DM al paciente poner NO) Glucosa en ayuno <130 mg/dL, Glucosa postorandial <180 mg/dL, HbA1c <8% (en pacientes ancianos)		
21	Recomendaciones según la Sociedad Española de Oftalmología: - Control de glucemia DM1 Y DM2, TA, Sobrepeso y lípidos. Se debe enviar al paciente al endocrino/internista/nefrólogo de ser necesario. - En pacientes con DM2 de larga evolución y con comorbilidades, mantener la HbA1c según las nuevas recomendaciones de la ADA. - Control de HAS, pacientes hipertensos <140/80 mmHg, salvo en enfermos de larga evolución con muchas complicaciones macrovasculares o microvasculares según la AHA.		
	NO DAR MEDIOS PUNTOS, SOLO ES SI O NO | ACREDITA CON 15/21		

PRÁCTICA 4

CERVICOVAGINITIS EN EL EMBARAZO			
#	**Criterios**	**Sí**	**No**
1	Se presenta y realiza ficha de identificación.		
2	AHE, APNP, APP, AGO: Menarca, Ritmo, G,P, A, C, O. IVSA, MPF, Fecha de último Papanicolau, Fecha de última mastografía. Dar edad gestacional en caso de que el alumno la corrobore. (Si falta alguno = NO) FUM: 01/06/2023 Obtiene FPP 07.03.2024 + EDAD GESTACIONAL 22.5 SDG (Si uno o ambos datos incorrectos = NO)		
3	Solicita signos vitales, talla y peso, glucosa capilar Si falta alguno = NO		
4	Interroga Padecimiento Actual Pregunta por datos de alarma haciendo énfasis en las caracteristicas del flujo vaginal (tiempo de evolución, coloración, olor, etc) y síntomas relevantes para el padecimiento (disuria, dispareunia, prurito vaginal).		
5	Pide autorización a la paciente, otorga una bata y solicita exploración física cefalocaudal Si falta alguno o realiza exploración en desorden = NO		
6	Pide autorización, explica el procedimiento a la paciente, realiza especuloscopia de forma adecuada y describe las lesiones cervicales Se puede apreciar cérvix en fresa con flujo espumoso		
7	Correlaciona clínica y Factores de riesgo en general (menciona AL MENOS 3) Uso de duchas vaginales, ropa interior de lycra, múltiples parejas sexuales, higiene inadecuada, alto consumo de alimentos ricos en levaduras, no utilizar preservativo, frecuencia de coito › 3/semana		
8	Solicita e interpreta estudios de laboratorio correctamente: Biometria hematica, Quimica Sanguinea, Grupo y rh, EGO, Exudado Vaginal, Urocultivo, VDRL, Prueba de VIH, Curva de Tolerancia a la glucosa, Determinación de proteinuria por tira reactiva. (si no solicita exudado vaginal = NO) *VIH, VDRL, tira reactiva → REFERIR COMO (-) EN CASO DE QUE EL ALUMNO LO SOLICITE		
9	Menciona principal agentes causales de cervicovaginitis Trichomonas, candida albicans, bacterias gram negativas, gardnerella vaginalis		
10	Solicita estudios de Gabinete, USG (si no conoce la utilidad de cada uno y las semanas en que se realizan todos = NO USG semana 11 y 13.6 para descartar aneuploidia, Edad gestacional, numero de fetos. USG semana 18-22 Estructural USG tercer trimestre cada 15 dias, valorar inserción placentaria, PFE, Liquido amniotico		
11	Hace diagnóstico de Cervicovaginitis por trichomonas		
12	Indica tratamiento Metronidazol tabletas vaginales una tableta cada 24 hrs por 10 noches, debe especificar que el tratamiento debe realizarse en pareja (si no conoce las dosis = NO)		
13	Pregunta directa: ¿cuál es el tratamiento en caso de candida albicans Miconazol crema vaginal aplicar c/12 hrs por 7 dias, Nistatina 1 ovulo/tableta vaginal al dia por 7 días		
14	Tratamiento para cervicovaginitis en caso de bacterias gram negativas Nitrofurazona un ovulo vaginal cada 12-24 hrs por 10-15 días		
15	Complicaciones principales de cervicovaginitis en el embarazo (menciona AL MENOS 3) Amenaza de aborto, aborto, amenaza de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, EPI		
16	Enfermedades de transmisión sexiual con las que se relaciona VPH y VIH		
	NO DAR MEDIOS PUNTOS, SOLO ES SI O NO | Acredita con 12/16		

PRÁCTICA 8

TRABAJO DE PARTO			
#	**Criterios**	**Sí**	**No**
1	Se coloca vestimenta correctamente para entrar a área de tococirugía. (Gorro y Botas) SIN CONTAMINARSE		
2	Se lava las manos en tres tiempos.		
3	Se coloca vestimenta correctamente SIN CONTAMINARSE		
4	Pide guantes de num correcto a enfermera. Se coloca guantes con tecnica cerrada SIN CONTAMINARSE		
5	Revisa que su material este completo: 2 pinzas para camplear el cordon umbilical, Riñon para colocar la placenta, Gasa montada para realizar asepsia, Instrumentos de corte y hemostasia.		
6	Realizar correctamente asepsia comenzando por vulva, region superior del pubis, zona interna de las piernas, hasta la región glútea formando un calzoncillo.		
7	Vestir al paciente con los campos esteriles: primer campo inferior que es de material impermeable se coloca en la parte posterior de la paciente, segundo campo, abdominal en la parte anterior de la paciente, colocar pierneras para cubrir piernas de la paciente		
8	Realizar proteccion de perine presionando en el perine posterior, retrayendelo hacia atrás para evitar lesiones. Maniobras Ritgen, Finlandesa.		
9	Episiotomia: Evitar desgarros de tercer y cuarto grados. Se recomiendo realizar Lateral. No realizar en mujeres sanas, se considera Violencia obstetrica. Indicaciones: Perine corto, Presentacion de cara, Parto instrumentado, Perdida de bienestar fetal. Aumenta la tasa de disfunciones del suelo pelvico.		
10	Ayudar a la paciente, explicándole que debe pujar en el momento que siente la contracción.		
11	Con la mano izquierda tomara la cabeza y con la derecha extraer el rostro del bebe.		
12	Realizar rotacion externa (Dependera del lado en que venia el rostro del bebe) Una vez terminando la rotacion, revisar el cuello fetal, buscando circular de cordon.		
13	Tomar con las palmas el cuello fetal y realizar suave descenso buscando la salida del hombro anterior. Indicar admnistracion de oxitocina 10 UI.		
14	Una vez fuera el hombro anterior, realizar movimiento hacia arriba para sacar el hombro posterior, deslizar nuestra mano por la espalda y ayudamos al nacimeinto completo del bebe. Manejo para distocia de hombros: Maniobra de Mc Roberts, Presion suprapubica.		
15	Colocar al bebe en el rezago materno para realizar el apego inmediato con la madre.		
16	Realizar pinzamiento tardio o inmediato de cordon umbilical, posteriormente realizar corte. Entregar el bebe el pediatra para los cuidados neonatales.		
17	Identifica etapa de ALUMBRAMIENTO: Revisa signos de descenso o desprendimiento placentario, confirmando que la placenta esta desprendida, realizamos leve tension del cordon umbilical, una vez que sale realizar torsion para facilitar la extraccion de las membranas. Realizar revision de placenta y membranas. 15 a 20 cotiledones.		
18	Admininistrar uterotonico a la madre 10 UI oxictocina.		
19	Describe tipos de alumbramiento Schultze: 80% de los casos, desprendimiento comienza por el centro, hematoma retroplacentario central, paraguas invertido, posterior aparece el sangrado. Duncan: 20% de los casos, sangrado previo a la expulsión, expulsando presentando cara materna.		
20	Colocar en bolsa correcta.		
21	Revisar Canal del parto para que no existan desgarros ni lesiones.		
	NO DAR MEDIOS PUNTOS, SOLO ES SI O NO | ACREDITA CON 15/21		

PRÁCTICA 9

CÁNCER CERVICOUTERINO			
#	**Criterios**	**Sí**	**No**
1	Se presenta con la paciente y realiza ficha de identificación		
2	Realiza Historia clínica completa y en orden. Haciendo énfasis en Antecedentes Gineco-obstétricos. (Completos)		
3	Interroga padecimiento actual (pregunta por metrorragia, "agua de lavar carne", pérdida de peso no intencional en los últimos meses, cervicovaginitis de repetición durante el último año) y solicita signos vitales con somatometría (si falta algo = NO)		
4	Realiza exploración física completa en orden cefalocaudal		
5	Identifica síntomas en etapa temprana: Flujo seroso o sanguinolento maloliente es común en la necrosis tumoral.		
6	Identifica factores de riesgo (menciona AL MENOS 3) Infección VPH, ETS, Paridad elevada, Uso de anticonceptivos orales >5 años, tabaquismo positivo, desnutrición, deficiencia de antioxidantes, bajo nivel socioeconómico, mujeres de 25 a 64 años, múltiples parejas sexuales, inicio de vida sexual temprana edad.		
7	**Pregunta directa:** ¿Cuáles son las vías de Diseminación en cáncer cervicouterino? Extensión local, Linfática, Hemática		
8	Menciona la prueba de TRIPLE muestra: Exocervix, Endocervix y Fondo de saco		
9	Solicita estudios complementarios de laboratorio y gabinete por sospecha de metástasis → BH, QS, AP de tórax,		
10	Menciona completa y correctamente la clasificación BETHESDA (Si no conoce la clasificación de BETHESDA ahí termina su estación)		
11	Pregunta directa: ¿Qué término recibe cuando la afección cruza por todo el epitelio y ha llegado a la membrana basal sin atravesar? Carcinoma in situ		
12	Menciona completa y correctamente la clasificación de la FIGO		
13	Interpreta correctamente el Frotis de la CC → Células displásicas compatibles con carcinoma epidermoide cervical.		
14	Tratamiento según estadio → Estadio 1B2 (histerectomía + linfadenectomía pélvica bilateral)		
15	Prevención El alumno conoce las vacunas disponibles para VPH →> Bivalente o Tetravalente Dos dosis en mujeres 9-13 años que no hayan tenido relaciones sexuales (0 y 6 meses), y tres dosis en mujeres >15 años e inmunocomprometidas (0.2 y 6 meses)		
	NO HAY MEDIOS PUNTOS, SOLO ES SI O NO | Acredita con 11/15		

PRÁCTICA 11

CHOQUE ANAFILÁCTICO			
#	**Criterios**	**Sí**	**No**
1	Se presenta. Interroga motivo de consulta.		
2	Solicita a Monitor los datos necesarios para realizar SAMPLE.		
3	Identifica reacción anafiláctica de acuerdo a criterios diagnósticos (menciona al menos 4) Identificación del tipo de choque		
4	Identifica estado de choque de acuerdo a parámetros establecidos -> índice de choque, uresis, Glasgow, presion pulso y llenado capilar (si falta algo = NO)		
5	Aplica dosis de epinefrina 0.01 mg/kg o Dosis máxima de 0.5 mg/kg. Via intramuscular a 90" VERIFICA QUE LA PERSONA ENCARGADA LO HAGA CORRECTAMENTE (si solo indica la dosis sin el cálculo ponderal por no conocer el peso del paciente = NO).		
6	A → Via aerea, verifica permeabilidad, Coloca como primera opcion mascarilla con reservorio a 15 L (Explicando que es la primera eleccion en choque anafilactico)		
8	B → Exploración fisica completa de torax (busca datos de dificultad respiratoria, realiza inspección, palpación, percusión, auscultación = si falta algo = NO)		
9	C → Verifica Signos de hipoperfusión, Coloca 2 vías periféricas explicando que una es para soluciones y otra para medicamentos de ALTO RIESGO en caso de necesitarlos, coloca sonda urinaria para calcular la uresis		
10	C → Al mismo tiempo Toma laboratorios Gasometría, Triptasa, Histamina, Biometria hematica, Quimica sanguinea, electrolitos Séricos		
11	D → Valora el Glasgow → Realiza revaloración cada 5 minutos.		
12	Identifica criterios para realizar SRI (menciona al menos 4 en general) y lo realiza de forma adecuada		
13	Explora completamente el paciente buscando signos de anafilaxia en orden cefalocaudal.		
	NO HAY MEDIOS PUNTOS, SOLO ES SI O NO | Acredita con 10/13		

RCP INTRAHOSPITALARIO			
#	**Criterios**	**Sí**	**No**
1	Identifica paro cardiorrespiratorio y activa código azul. INTEGRA EQUIPO DE RCP		
2	Coloca tabla de rigida debajo del tórax del paciente. SE INDICA A LA PERSONA DESIGNADA TOMAR TIEMPO		
3	Inicia compresiones toracicas de adecuada frecuencia (100-120 x min) y adecuada calidad.		
4	Inicia ventilaciones con BVM con una relación de 30:2 si no hay via aérea avanzada o 1 x cada 6 segundos si hay vía aérea avanzada		
5	Coloca monitor/ desfibrilador y evalúa ritmo por 5 segundos		
6	Realiza de forma adecuada la toma de tiempos en compresiones y administración de fármacos e informa al resto del equipo		
7	Identifica ritmo desfibrilable (FV/ TVSP) o no desfibrilable (asistolia/ AESP) y administra descarga si amerita		
8	En caso de requerir desfibrilación carga energía de desfibrilador a 120-200 J si bifásico o 360 J si monofásico		
9	Realiza compresiones inmediatamente después de la desfibrilación		
10	Reevalúa ritmo cada 2 minutos por 5-10 segundos, suspendiendo compresiones durante evaluación		
11	Administra adrenalina 1 mg IV: - Tras 2da descarga si ritmo desfibrilable - Tras 1er ciclo si ritmo no desfibrilable		
12	Tras 3er descarga de desfibrilador administra: Amiodarona 300 mg seguidos de 150 mg ó Lidocaina1-1.5 mg/kg seguidos de 0.5-0.75 mg/kg.		
13	Pregunta directa: ¿ Cómo podemos confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET? Capnografia		
14	Identifica datos de retorno de circulación espontánea (si no conoce los tres = NO) Pulso y presión arterial | 2. Aumento repentino y sostenido de la PETCO2 > O = 40 mmHg | 3. Ondas espontáneas de presión arterial con monitoreo intraarterial		
15	Indica cuidados posparo		
16	**Pregunta directa:** Menciona 6 causas reversibles de paro cardiorespiratorio		
	NO HAY MEDIOS PUNTOS, SOLO ES SI O NO | Acredita con 12/16		